

17장. 알레르기 질환

1절. 알레르기 총론

※ 알레르기 : IgE 관련 여부와 관계없이 표적기관에 염증이 형성되고, 이로 인해 발생하는 과반응 질환

1. 알레르기에 관계있는 신체성분

- I, II, III형은 즉시형 반응, IV형은 지연형 반응

	I 형 (Type1)	II 형	III형	IV형
반응 종류	즉시형	항체 매개형	면역복합체 매개형	지연형
항체	IgE	혈류항체 (IgG, IgM)		세포성 항체
특징	유전성이 중요 감작이 필요	-	-	유전성 중요치 않음 접촉성 감작
침윤세포	호염기구, 호산구	-	호중구	단핵구(호염기구)
주된 알레르기 질환	아토피성 질환 (천식, 아토피성 피부염, 알레르기 비염, 두드러기, 아나필락시스)	자가면역질환, 용혈 빈혈, 혈소판 감소증, 수혈반응, 근무력증, 갑상선 중독증 Good pasture's syx	혈청병, 사구체 신염, 혈관염, 과민성 폐렴, 알레르기성 폐장염, 전신 홍반 루푸스, 류마티오이드 관절염	접촉성 피부염, 나병, 결핵, 악성 빈혈, 갑상선염, I 형 당뇨병, 이식 거부

2. 알레르기에 영향을 주는 요인들 ★

1) 유전	- 알레르기 반응을 일으키기 쉬운 체질이 유전함 (질환이 유전X) - 자녀에게 질환이 나타날 확률 : 양친 질환 시 70% / 모친만 질환 시 50% / 부친만 질환 시 30% - 알레르기성 질환의 가족력 가진 아이에게 할 처치 - 모유 권장 - 영아기 이유식은 한 가지씩 소량으로 시작 - 저알레르기성이고 익힌 음식
2) 자율신경	자율신경 실조상태 ⇄ 알레르기
3) 호르몬	- 월경 전 : 천식발작 ↑ - 사춘기 : 알레르기 반응 ↓
4) 심리적 요인	어린이는 심리적 미숙·미발달 → 정서장애 多 → 자율신경 균형 및 내분비계 실조 → 알레르기 반응 ↑
5) 연령	- 알레르기는 어른보다 어린이에서 多 - 연령별 원인과 증상 - 영아기 : 우유알원, 이유식 → 식품항원으로 피부의 발진, 습진, 설사, 복통 - 유아기 : 외출, 흡입성 항원 노출 기회 증가 → 기관지천식과 같은 기관지염 발생, 감기 증상 되풀이 - 학동기 : 화분증, 접촉성 피부염, 담마진 - 사춘기 : 항원 노출에 대해 내성, 항원 침입에 대한 방어체계 형성 - 성인기 : 아토피성 질환 ↓, 직업성/감염성 알레르기 ↑
6) 계절과 기상	- 습진은 봄에 발병 ↑ - 계절이 바뀔 때 : 알레르기성 질환 多 - 기온 저하 및 찬바람 불 때 : 한랭에 의한 두드러기 多 - 꽃가루 날릴 때 : 비염, 결막염 多
7) 대기오염	호흡기계와 기관지천식, 과민성 폐장염에 특히 악영향
8) 피로	피로는 저항력을 약화시킴

3. 알레르기 질환의 특성

1) 알레르기 행진(Allergic march) ★

: 나이에 따라 알레르기 질환의 양상이 서로 다르게 나타나는 경향

생후 1개월	생후 2개월	생후 3~4개월
식품 알레르기에 의한 위장염	아토피 피부염	세기관지염
돌 이후	3세 경	4세 이후
천명성 기관지염	전형적인 천식	알레르기 비염

4. 알레르기 질환의 진단

1) 병력 가장 중요한 것 : 병력의 청취

(1) 증상	재채기, 콧물 코막힘 기침, 호흡곤란, 천명 위장장애, 설사, 구토 등 알레르기는 비·폐·신에 영향
(2) 발병상황	하루 중 시간, 계절, 장소 등
(3) 환경 및 생활주변	주거 형태, 통풍 및 채광, 근처 공장 여부, 애완동물 등
(4) 과거력	아토피성 피부염, 모세기관지염 등의 과거 병력, 백신 과민반응 등
(5) 가족력	알레르기성 질환은 유전적 소인을 띠
(6) 유발인자 ★	① 물리적 인자 : 담배 연기, 곰팡이 냄새, 페인트 냄새, 먼지 흡입 등에 의한 기도점막자극 등 ② 기후인자 : 한랭, 고온, 다습, 건조, 광선 등 ③ 신체적 인자 : 수면부족, 과로, 과식, 월경, 감기. 갑상선기능항진증 등 ④ 정신신경적 인자 : 우울, 상심, 낙담, 신경질, 흥분, 불화 등 ⑤ 감기 등의 감염증

2) 인체를 대상으로 하는 검사

(1) 알레르기 피부 시험 (Allergy skin test, 피부 반응 검사)

조사 대상	시험 종류	의의
즉시형 반응	① 단자시험 (prick test)	- 양성 반응은 환자의 비만세포나 호염기구의 표면에 어떤 특정 항원에 대한 IgE가 부착되어 있다는 것만을 의미 - 즉, 양성 반응을 나타낸 항원이 그 병을 일으킨 원인 항원이라고는 할 수 없음
	② 소피시험 (scratch test)	
	③ 피내시험 (intradermal test)	
지연형 반응	④ 첩포시험 (patch test)	접촉 피부염 진단

(2) 유발검사 (Provocation test)

- 정의 : 원인으로 의심되는 항원을 환자에게 직접 투여하거나 원인적인 조건을 만들어 주어 증상이 나타나는지를 알아보는 검사
- 종류 : 항원 흡입, 히스타민 흡입, 운동, 물리, 약물, 식품경구, 환경유발시험 등
- 단점 : 환자가 자연적인 상태에서 항원에 노출되는 것과 똑같은 상태로 노출시킬 수 없음

3) 실험실(검사실) 검사 ★

(1) IgE치 측정

	분류	측정 방법	특징
IgE	총 IgE	PRIST	- 총 IgE값은 정상치 범위가 넓어서 결과를 판단하기 어려움 - 알레르기 환자의 50% 정도에서 IgE값은 정상 범위에 속하므로 주의
			- 특정 항원에 대한 알레르기 여부를 알아보는 검사 - 요즘 잘 안씀 (∵ 예민도 낮음, 사용불편, 고가장비)
	특이적 IgE	MAST	- 원인 항원을 찾기 위해 환자에서 채혈하여 식품관련, 호흡기 항원 찾아내는 검사 - 종류 : 음식 MAST 검사, 흡입 MAST 검사 예) 식품 알레르기 있는 아이가 음식 항원 48가지에 중 어떤 것에 대해 알레르기가 있는지 확인할 때 사용함
			요즘에는 MAST 대신 CAP을 사용함 (∵MAST의 단점 보완)

(2) 호산구 검사

- 객담이나 콧물의 호산구를 검사하면 천식, 비염 진단에 도움
- 호산구 수 증가 : 아토피 질환, 기생충증, 약물에 의한 반응, 침윤성 폐질환 등이 있을 때
- 호산구 수 감소 : 부신피질 스테로이드제 투여
- 백분율 보다는 총 호산구수 측정이 신빙성 ↑
- 호산구 증가 시기는 항상 변화하므로 되풀이해서 검사하는 것이 중요

5. 치료

1) 예방요법

(1) 원인 항원의 제거 : 특수항원

- 식품 알레르기의 주된 항원 : 계란, 우유, 곡물(밀), 생선, 고기, **콩** 종류, 초콜릿 등
※우유 알레르기는 생후 2~4주에 나타날 수 있음 → 두유나 육즙을 우선 사용 or 끊어서 사용
- 알레르기 비염이나 기관지천식 등의 주된 항원 : 집 먼지, 먼지진드기

(2) 자극성 물질로부터 회피 : 공통 항원

- 찬바람, 신나, 락카, 니스, 연탄가스, 곰팡이 냄새, 특정한 음식 냄새 등의 자극성 냄새 및 나무 냄새
- 따라서 집에 칠을 할 때는 환기가 잘되는 여름철을 택함

2) 면역요법 (감감작요법, Hyposensitization)

- 정의 : 원인으로 확진된 알레르겐을 소량씩 점진적으로 늘려가며 주입하여 알레르기 반응이 경감·소실되도록 하는 치료법
- 종류 : 피하면역치료(SCIT), 설하면역치료(SLIT)

3) 교육

- **고위험군 영아¹⁾의 경우 최소 생후 6개월 동안 완전 모유 수유(혼합수유금지)를 권장**
- 특정 음식물은 늦게 먹도록 권유 : 우유 및 유제품(1세 이후) | 계란(2세 이후) | 견과류(3세 이후) | 해산물(3세 이후)

4) 섭생

- **통풍이 잘 되는 옷**
- 일광욕으로 피부를 단련 | 규칙적인 운동(아침에 맨손체조 등) | 일정하게 일상생활의 리듬을 유지
- 갑작스럽게 **찬공기에 노출되지 않도록** 함 (찬물, 찬 공기, 찬 음식 등 피하기)
- 과잉보호하지 않고 적극적인 성격으로 키움 & 자립심과 자신감을 심어 심인적인 요인을 제거
- 감기 예방에 신경을 쓰고, 감기에 걸리면 즉시 치료
- 목욕 후에는 체온이 떨어지게 되므로, 목욕은 저녁때나 밤보다는 **오후 2~3시경에 함**
- 습도가 너무 높거나 낮은 경우에는 기관지천식을 악화시키므로, 실내의 습도는 50~60%로 유지시키는 것이 좋음

1) 부모·형제·자매 중 알레르기 질환이 있는 경우

0. 개요

- 천식: 기도의 염증에 의해 발생한 기관지 폐쇄를 특징으로 하며, 만성 호흡기 질환인 알레르기 천식이 대표적인 임상 양상
- 천식의 병태생리는 기도의 만성 염증으로 인한 기류 폐쇄, 기도의 과민성, 점막 부종 및 기도 개형이 있음
- 증상: 알레르기 현상인 부종, 과다분비와 평활근의 수축 & 기침, 가래와 기도 폐쇄에 의한 호흡곤란 증상
- 이러한 증상들이 만성 염증에 의해 지속/반복하면서 장기간에 걸쳐 나타나고, 기도 개형을 일으키면서 기도 폐쇄의 증상이 더욱 심하게 나타나며 때로는 비가역적인 폐 기능 저하까지 진행됨
- 약 80% 이상이 6세 이전에 처음 나타나며 약 30%는 1세 이전에 발병

1. 원인

1) 유전적 소인

- 3촌까지의 가계에 천식(1/2) 또는 알레르기(1/4) 질환이 있는 경우 → 총 3/4 (소아에 있어서는 천식 발증에 관계되는 많이 요인 중 유전/알레르기 소인의 관여가 큼)
- 천식아의 약 2/3에서 영유아기 습진의 기왕력이 있음
- 천식과 관련된 유전자가 15번 염색체에 있는 것으로 알려짐

2) 환경적 요인 ★

(1) 알레르겐	• 성인은 흡입성 항원 多 3세 이하 유아는 식이성 항원 多 • 흡입성 항원 : 실내먼지, 먼지 진드기, 곰팡이 • 식이성 항원 : 우유, 계란, 콩류, 어패류 (특히 신생아는 위 장관의 미숙으로 인하여 거대분자 항원의 위장관 점막 침투를 막는 힘이 감소되어 있어서 첫 3개월 이내에 항원감작이 일어나 알레르기 질환이 발생하기 쉬움), 단백질이 완전히 소화되지 않은 상태
(2) 호흡기 감염	• 1세 이하의 어린 영아에서 천명을 동반하는 폐쇄성 기도질환을 가졌던 환아의 상당수에서 나중에 천식이 유발됨 • 천식의 발작에는 바이러스 감염이 세균감염보다 더 관련이 많음 • 영아 천식을 유발하는 가장 흔한 바이러스 : respiratory syncytial virus (RSV) • 2세 이후 유아는 rhinovirus 감염이 흔함
(3) 환경 오염물질	담배연기, 곰팡이, 페인트 냄새, 기후변동, 바람, 오존, 초음파 가습기로부터의 수증기 등
(4) 아스피린 특이 체질반응	기관지 천식 비폴립 아스피린 불내성 → 잘 듣지 않는 천식 소아에서 의심해볼 수 있음!
(5) 기타	① 운동성 천식 : 운동으로 차고 건조한 공기를 과호흡하여 천식이 발생 ② 정서적 천식 : 심신 상관으로 정서적 불안이 천식에 악영향

2. 증상 ★

- 천식의 3대증상 : 천명 | 호흡곤란 | 기침
- 천식은 사춘기에 호전, 월경전·임신·폐경기에 악화

천명 (wheezing)	• 쌉쌉거림, 그르렁 소리 • 영유아는 객담을 잘 배출할 수 없고, 해부생리적으로 기도가 좁아 발생
호흡곤란 (dyspnea)	- 모두 호기성, 발작성 - 소아는 호흡 관여 평활근, 흉곽과 횡격막의 구조가 미숙하여 기도 폐쇄가 더욱 심하게 나타남 - 호흡곤란이 정도 이상으로 심해지면 청색증, 발한, 안면창백 등이 나타나며, 빈맥을 비롯해서 심혈관계에도 부담을 줌
기침	- 연소아, 영유아: 습성 기침 多 / 연장아: 乾咳(헛기침) 多 - 진해제 보다는 기관지확장제가 더 좋은 효과 (가래 객출이 중요하므로)
발열	특징적 증상은 아니지만 보통 37~38도의 발열 (고열이 나는 경우는 드물)

3. 치료

- 치료 목표 : 증상 재발 최소화 → 정상적 학교생활, 수면 유지, 자유로운 운동 / 약물 부작용X / 심한 천식으로의 진행을 조기 차단
- 치료 종류 : 약물치료, 환경관리(알레르겐 제거), 식이요법
- 약물 종류
 - ① 질병 조절제 (controller) : 항염증 및 지속성 기관지 확장 효과 등을 통해 증상을 조절 (흡입 스테로이드, 경구 스테로이드, 류코트리엔 조절제 등)
 - ② 증상 완화제 (reliever) : 신속히 기도 수축을 회복시켜 증상을 개선 (속효성 흡입 베타 2 항진제, 흡입 항콜린제, 속효성 테오필린 등)

4. 진단

- 자세한 병력과 임상소견, 기관지 유발시험으로 기관지 과민성을 증명해야 함
- 기관지 확장제 투여나 폐 기능 검사로 기도 폐쇄의 가역성을 확인하고, 원인 항원을 찾거나 추적 관찰 해야함
- 기침과 천명이 반복적이고, 특히 운동, 바이러스 감염, 알레르겐의 노출로 인해 증상이 악화되는 소견으로 일단 천식을 쉽게 진단 可
-

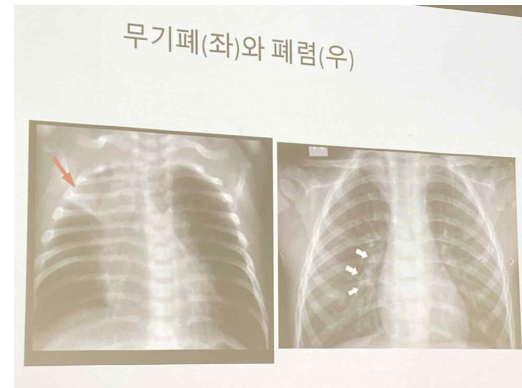
1) 검사

① 혈액 호산구 : 천식 발작시 증가 / 증상이 없을 때 감소

② 흉부 X선 : 보통 정상 (급성 발작인 경우 폐의 팽창 소견)

↳ 반점 침윤과 분절 무기폐 가능성有
→ 기관지폐렴과 구별해야 함

※ 왼쪽 사진 참고



2) 감별진단 - 기관지 천식 vs 감염형 천식 ★★

		아토피형 천식	감염형 천식
병력	발병연령	소아, 청소년	성인
	호발 계절	대개 계절성	한냉·계절의 변환기
	유발인자	식물, 흡입항원	호흡기 감염
	증상	가끔 뚜렷	지속적
	기침	발작 후기에 기침 시작 기침으로 인해 발작이 경미해짐	발작 초기에 기침 시작 기침이 발작을 야기함
	객담·콧물	점액성	화농성
	점액상태	clear & foamy	thick and discolored
	재채기/눈가려움/콧물	많다	적다
	기타 알레르기 질환 합병	많다	적다
	발열	없다	가끔
	항생제	무효	경과를 단축 또는 증상 호전
신체 소견	비점막	창백, 부종	발적, 부종
	목젖	창백, 투과성	발적, 불투명
	편도	창백	발적 또는 정상
	인두측벽	창백	발적
검사 소견	부비동 x-ray*	투명, 점막의 두께 상대적	불투명, 가끔 편측성
	말초혈액 백혈구수	정상	상승, 정사
	말초혈액 호산구증가	가끔	드물다
	skin test 양성	흡입항원에 뚜렷	뚜렷하지 않음

*x-ray : 투명은 검정색 | 불투명은 회백색을 의미

5. 임상적 접근 (천증)

변증	증상	치법	처방
풍한천급 ★	가래소리가 심함 객담이 맑고, 하얗다 (청백) 사지가 찬	온폐화담	소청룡탕, 소자강기탕
화열천급 ★	얼굴과 입술이 붉고 건조 갈증이 심함 기침 시 가슴 통증 호흡이 가쁘고 가슴이 답답함		마행감석탕, 정천탕
폐허작천	기침이 심할 때 숨이 참 사지가 찬 얼굴이 창백 쉽게 피곤 가래가 심하지 않음 식은 땀이 나고, 찬 것을 싫어함	양음윤패	백합고금탕
비기허약	식욕 없고 배가 금방 부름 얼굴색이 누렇다 해수담다 성장부진	건비화담	육군자탕
신허불납	면색 황백 형한지냉 하지불온 각연무력	보신고본	금궤신기환

*풍한천급, 화열천급은 발작기 / 폐허작천, 비기허약, 신허불납은 완해기

3절. 알레르기성 비염

0. 개요

- 알레르기 비염: 흡입한 알레르기 물질이 비점막에 접촉하여 면역반응을 일으키기 때문에 생기는 질환으로, 반복성 또는 계절적으로 코가 막히거나 콧물이 나오는 경우를 말함
- 상기도 알레르기의 발병은 초등학교 시기에 가장 많으나, 이 가운데 알레르기 비염은 5세 이후의 소아에서 가장 많이 발생

1. 원인과 분류

- 발생 : 흡입한 알레르기 물질 → 비점막 접촉 → 면역반응을 일으켜 생기는 질환
- 알레르기 비염은 5세 이후의 소아에서 가장 많이 발생
* 10세 이전 : 남아 ↑ | 10 ~ 20세 : 여아 ↑

원인	• 주로 집 먼지 진드기 등의 흡입항원 • 식품항원도 관여하긴 함
분류	• 계절성 알레르기 비염 : 화분, 곰팡이 등의 원인 → 소양감O, 대개 유전적 소인 • 통년성 알레르기 비염 : 실내 항원이 원인 → 소양감X, 아침에 심한 증상

2. 증상 ★

- ★ 알레르기 비염 3대 증상 : 재채기 | 코막힘 | 과도한 콧물
- 알레르기 비염은 즉시형 과민반응에 의해 나타나는 것으로 면역글로불린 중 IgE와 비만세포 또는 호염기구 사이에 항원-항체 반응이 일어나 각종 화학전달물질이 비점막에 병적상태를 유발하여 증상이 나타남
cf. 후비루 : 콧물 양이 너무 많아져서 목 뒤로 넘어가는 증상 (→ 축농증, 만성비염의 특징으로 알레르기 비염과 구분해야 하는 증상!)
- 국소 소견 : 비점막 및 비갑개 점막의 종창과 창백
- ★★ 특징적 안면부 망진 소견

allergic salute	: 손으로 코를 비비며 밀어 올리는 행동
transverse nasal crease	: allergic salute 행위를 오랫동안 지속해서 생긴 콧등의 주름
Dennie- Morgan folds	: 눈 비빔으로 눈 밑에 생긴 여러겹의 주름
allergic shiner	: 눈 주위의 피부색이 검푸르게 착색된 것 (비강 주위, 특히 안검의 정맥 순환이 원활하지 못하여 발생)
Adenoid face	: 코막힘으로 인한 구강호흡 지속 → 길고 후퇴한 하악이 특징적인 얼굴
throat clearing	: 연구개 및 인두 부위의 이물감으로 이를 제거하려는 버릇 (=헛기침 하는 것)

3. 감별 진단

1) 알레르기 비염 vs 감염성 비염(감기) ★

	알레르기 비염	감염성 비염 (감기)
발병	급격하게 자주 발생	코막힘, 콧물, 발열이 나타나면서 서서히 발병 (7~14일 지속)
재채기	현저하다	없거나 가볍다
코의 분비물	초기 : 엷고 물과 같으며 양이 많다 후기 : 진해지나 대개 무색	진하고 점액성이며 점점 많아진다 처음에는 무색 → 곧 회백색~노란색 콧등이나 윗입술의 피부에 자극을 준다
코의 폐색증	있을 수도 있다	심함 (차차 없어짐)
눈의 증상	자주 본다 (특히 연장아)	대개 없다
전신 증상	대개 없다	자주 본다
전염성	없다	현저하다

2) 기타 질환과의 감별진단

부비동염 ★	- 부비동염은 감기로 합병되며, 증상이 10일 이상 지속 - 콧물이 끈끈, 누런색 후비루 입에서 악취
호산구증다성 비알레르기 비염	비즙 내 호산구수 25% 이상, 비용종을 동반 多
혈관운동성 비염	- 심한 코막힘, 비특이적 자극(온도, 습도 변화, 담배 연기 등)으로 악화 - 코 가려움증↓, 맑은 콧물↓, 눈 증상 X
tic 및 ADHD	- 코를 찡긋거리고 눈 밑이 검게 되는 특징이 있는 알레르기 비염 환아와 유사하므로 tic과 구분 - 코 때문에 집중 힘든 것(비성주의산만)과 ADHD 구분

4. 합병증

- ① 중이염과 부비동염 → 특히 삼출성 중이염
- ② 천식 : 알레르기 비염의 60%에서 천식을 동반
- ③ 비용종(nasal polyp) : 통년성 알레르기 비염의 합병증

5. 임상적 접근 (비구·분체) ★★ 무조건 나오고, 요즘 CPX 형식으로 나오니까 무조건 외우기 무조건!!!

변증	증상	치법	치방
풍한증	재채기 多 코 분비물 많고 청희(淸稀) 비점막 종대·창백	조화폐기 거한산사	소청룡탕, 계지탕
풍열증	재채기 多 담황색 콧물 비점막 정상, 심하면 약간 충혈	소풍청열	여택통기탕, 형개연교탕, 방풍통성산
비허증★	재채기 많지 않음 코막힘이 심하고 오래 지속 비점막 창백, 가벼운 부종 전신증상 : 비의 운화기능↓, 피로, 변당	익기승양 보비고위	보중익기탕, 옥병풍산
폐신음허★	코막힘 콧물이 백색 or 황색 비점막 비교적 발적, 충혈 (코피 잘 남) 후비루 있는 경우 : 해수, 구취, 구건, 지도설	자신양음 보폐익기	형개연교탕, 육미지황환, 좌귀음

4 절. 아토피 피부염

- 아토피 피부염 : 재발이 잦고, 만성으로 경과하는 염증성 질환 (아토피 피부염 = 영아습진 = 알레르기 습진)
- 증상 : 심한 가려움증, 홍반 구진과 인설을 동반한 건성 피부 병변

1. 원인

- 유전, 환경과 면역학적 요인 / 환경 중 식품, 집먼지진드기와 세균과의 연관성이 거론됨
- 유전은 모계 유전 형태가 현저하고 성인 환자의 자녀 60%에서 아토피 피부염을 가지고 있고, 양쪽 부모가 모두 증상이 있으면 80%에서, 한쪽 부모만 증상을 가진 경우 자녀의 55%에서 증상을 나타냄

2. 진단

: 혈액검사에서 혈청 IgE 상승, 특이 IgE 항체의 측정 등이 도움

1) 한국인 아토피 피부염의 진단기준 (2005, 대한피부과학회)

주소건 2개 이상, 부조건 4개 이상 만족시 아토피피부염으로 진단	
주소건	① 가려움증 ② 특징적인 피부염 모양 및 호발 부위 - 2세 미만 : 얼굴, 몸통, 팔다리가 퍼지는 부위의 습진 - 2세 이상 : 얼굴, 목, 팔다리가 접히는 부위의 습진 ③ 아토피의 과거력 및 가족력
부조건	① 피부 건조증 ② 백색잔비늘증 ③ 눈 주위의 습진 병변 혹은 색소 침착 ④ 귀 주위의 습진 병변 ⑤ 입술염 ⑥ 손, 발의 비특이적 습진 ⑦ 두피 인설 ⑧ 모공 주위 피부의 두드러짐 ⑨ 유두 습진 ⑩ 땀이 날 때 소양증 동반 ⑪ 백색피부그림증(백색피부묘기증) ⑫ 혈청 면역글로불린E(IgE) 증가 등

3. 감별진단

① 지루성 피부염 ★	- 두피에서 시작 - 귀와 접촉된 피부, 같은 쪽의 코와 눈썹, 눈꺼풀에 끈끈한 갈색 인설을 동반
② 알레르기 접촉 피부염	원인 알레르겐에 노출된 부위에 국한되며, 전형적으로 굴곡 부위는 침범 X
③ 건선 ★	- 가장자리가 뚜렷하고, 은백색의 비늘로 덮여 있음 - 홍반 구진이 다양한 크기와 모양의 판을 이루고 있으며, 뜯으면 점상출혈
④ 어린선	- 아토피 피부염에 비해 인설 크기 ↑, 가려움 ↓ - 주로 사지의 바깥쪽에 양측으로 생김



① 지루성 피부염 ② 알레르기 접촉 피부염 ③ 건선
④ 어린선

4. 임상적 접근 ★

- 한의학에서 내선(奶癬), 태선(胎癬), 태렴창(胎斂瘡), 습진(濕疹), 습창(濕瘡) 등의 범주에 속함

변증	병형	처방
(1) 급성기	습열형	승마갈근탕, 소풍산, 선방패독산
(2) 아급성기	비허습성형	내소화중탕, 평위산 加 황금 황련
(3) 만성기 ★★	음허혈조형	생료사물탕, 당귀음자, 온청음

5절. 두드러기와 혈관부종

- 두드러기 : 모세혈관의 확장과 투과도 증가 → 상부 진피의 부종 → 심한 가려움증과 갑작스럽게 나타나는 얼룩반점이 특징인 질환
- 병변이 생기는 조직에 따라 구분 : 두드러기(진피 상층부), 혈관부종(진피 심층부와 피하조직)
- 두드러기: 붉게 부어오르는 얼룩 반점을 특징으로 경계가 뚜렷한 팽진과 누르면 사라지는 발진이 있음
- 혈관부종: 얼굴, 혀, 사지와 생식기에 주로 나타나고 상부 기도와 위장관 점막에도 발생
- 두드러기와 혈관부종은 약 50%에서 같이 생김

1. 발생기전

- 비면역성 요인: 화학적 히스타민 유리물질, 물리적 요인, 콜린성 효과 등
- 면역성 요인: 보체매개성, IgE 매개성

이러한 요인들이 비만세포 또는 호염기구에 작용하여 화학매체들(히스타민 등)이 유리되고 이들은 소혈관에 작용하여 모세혈관이나 소정맥이 국소적으로 투과성이 증가되어 단백질과 체액이 혈관 밖으로 누출되어 피부의 용기현상이 나타남

- 요인들이 단독적으로 작용하기보다는, 주로 서로 연계되어 나타남

2. 원인

식품과 약물 두드러기	- 어패류(고등어, 게, 새우, 조개류)가 원인이 되는 경우 多 - 그 외 돼지고기, 초콜릿, 땅콩류, 딸기 등 - 해열진통제, 설파제, 페니실린이 원인이 되기도 함
흡입 또는 접촉성 항원	- 흔한 원인은 아니지만, 화분 알레르기 환자에게 종종 나타남 - 음식물 또는 동물의 침, 곤충 등에 접촉한 경우 두드러기 발생 可
감염	- 기생충, 바이러스(EBV, 간염 바이러스, adenovirus, enterovirus 등), 세균, 진균 등
물리적 원인	- 온도의 변화나 굽거나 진동을 주거나 압력을 가하는 등의 물리적 자극에 의해 증상이 나타남 - 한랭 두드러기, 콜린성 두드러기, 피부 묘기증, 압력 두드러기, 일광 두드러기, 수인성 두드러기 등

2. 증상

콜린성 두드러기 ★★	• 만성 두드러기의 5~7% • 정의 : 땀샘과 근육에 분포하는 콜린성 신경섬유가 일으키는 두드러기 • 원인 : 심부 체온 1°C 상승 시 발생 (예. 과도한 운동, 정신적 스트레스, 뜨거운 목욕 등) • 특징 : 1-2mm의 아주 작은 팽진 多 주위에 1-2cm의 홍반성 발적 • 위치 : 주로 체간부 (얼굴, 손, 발은 X) • 증상 - 가려움보다는 따가움 호소 - 발한, 복통, 현기증 동반 - 팽진은 30~60분 후 소실
한랭 두드러기	• 만성 두드러기의 1~3% • 찬 공기, 찬물, 얼음에 노출되면 나타남 • 노출 후 몸이 다시 더워질 때 발생하는 경우가 多
수인성 두드러기	• 물이 닿은 부위에 아주 작은 팽진이 모공 중심으로 발생 (물 온도와 관계X)
만성 특발성 두드러기와 혈관부종	• 6주 또는 그 이상 지속되는 경우. 만성형/간헐형으로 구분

3. 진단

- 두드러기의 임상적 진단은 비교적 쉬우나 만성적 경우 진찰 당시 팽진이 없을 수도 있음
- 유발검사가 결정적 (접촉성 두드러기, 피부요기증, 한랭 두드러기, 콜린성 두드러기, 열 두드러기 등)
- 가장 중요한 것은 원인을 밝히는 것!
- 급성: 최근 어떤 질환을 앓았거나, 약물을 복용했거나, 특정 음식물을 섭취한 경우가 많음
- 만성: 계절적 요인, 환경적 요인, 정신적 요인, 음식물, 약물, 물리적 인자와의 관계를 잘 조사할 필요 있음 / 전신질환에 대한 이학적 검사, 검사실 검사 병행도 좋음

4. 치료

- 원인 확인된 경우는 회피요법
- 약물요법: 항히스타민제, 아드레날린계 약물, 경구 스테로이드 등을 사용

4. 임상적 접근

- 한의학에서 은진(癩疹)에 해당함
- 일반적 처방 : 방풍통성산, 가미보화탕, 가미청기산(초기) 등
- 증상별 처방 : 형방패독산(피부 요기증) | 이종탕(한성 두드러기) | 황련해독탕(온성 두드러기) | 마행감석탕(태양 광선에 의한 것)

曰: 6~11월까지 교수님께서 5분컷 내셨기 때문에 사실상 수업을 안 한 것이나 마찬가지입니다... 교수님께서 하신 말씀을 최대한 옮겨적어보았습니다!

6절. 식품 알레르기

- 두드러기와 비슷
- 우유와 같은 식품을 먹고 두드러기 나고, 설사하고, 토하고, 아토피 증상 나타나고, 천식 비염 오고, 심하면 아나필락시스가 나타나기도 함
- 치료는 일반적인 식이성 항원을 잘 없애주는 것이 가장 중요함

7절. 눈의 알레르기

- 결막염에 해당
- 알레르기 결막염 / 봄철 각결막염으로 나눠서 치료
- 세간명목탕 가감방을 주로 사용하며, 세간명목탕은 사물탕의 가감방

8절. 곤충 알레르기

- 모기한테 물려도 병원 가야 해요~ 라고 하는 아이들..

9절. 약물 알레르기

- 환자가 이미 본인이 알고 있는 경우가 많기 때문에, 진료 받으러 와서 미리 말함
- ex) 아스피린, 페니실린, 설파제 등
-

10절. 혈청병

- 혈청병: 이종항원 투여후 전신적 과민 혈관염 등의 면역 장애 증상들이 나타나는 질환
- 이종항원 주사 후 7~12일 에 나타나지만 늦게는 3주 후에 나타나기도 함
- 치료는 항히스타민제와 아스피린을 사용하며 심하면 스테로이드 치료가 효과적

11절. 아나필락시스

- 정의: 비만세포나 호염기구에서 분비되는 화학매개물질에 의하여 피부, 호흡기, 소화기, 심혈관계 증상이 발생하는 급성 반응
- 원인: 약물(특히 penicillin), 조영제, 식품, 우유, 땅콩, 곤충의 독 등
- 증상: 초기에는 입 주위나 얼굴에 따끔거리는 느낌, 열감, 연하곤란, 불안, 소양감 동반 발한 / 경련성 복부 통증, 다른 평활근의 수축이 있다가 의식을 잃기도 함
- 치료: 일차적으로 에피네프린을 주사하며, 수축기 혈압 80mmHg 이상이 되도록 유지